

Le système de santé au Maroc

PR N Tachfouti, MD, MPH, PhD

Contexte national

Transformation sociale et politique

■ Avant le 9 mars

- Consolidation de la démocratie et des droits
- Réforme de la Couverture Médicale de Base (CMB)
- Initiative Nationale de Développement Humain
- Mouvements de revendications sociales

■ Après le 9 mars

- *Nouvelle constitution*
- **Généralisation du RAMED en 2012**

Article 31 de la constitution

- «L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit : aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'Etat...»

La loi 34/09

Décret n° 2-14-562 du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) pris pour l'application de la loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins.

Analyse de la situation

Principaux défis

1. Difficulté d'accès aux soins
2. Déficit aigu en ressources humaines
3. Insuffisance de financement
4. Crise de confiance [image]
5. Déficit de gouvernance
6. Double fardeau de la transition épidémiologique

La reforme???

Faits marquants

- Discours Royal du 29 Juillet 2020 :
 - SA MAJESTE a annoncé la généralisation de la couverture sociale à partir de 2021 (durant 5 ans)
- 
- *Réforme des systèmes et programmes sociaux*
 - *Généralisation de l'AMO et allocations familiales*
 - *Autres couvertures sociales: retraite et l'indemnité pour perte d'emploi*

Faits marquants

- Discours Royal de la fête du trône 2021:
 - la souveraineté sanitaire est une composante essentielle de la sécurité stratégique du pays,
 - SA MAJESTE a lancé un projet avant-gardiste de fabrication de vaccins, médicaments et matériel médical, indispensables pour le Maroc.

loi-cadre 06/22

relatif au système de santé national

- Adoptée le 13/07/22 en conseil des ministres
- Adoptée le 25/10/2022 par la chambre des conseillers
- Objectifs
 - Développer des infrastructures de base,
 - Garantir l'accès équitable des citoyens aux services sanitaires de qualité,
 - Remédier à la pénurie des ressources humaines

Piliers de la réforme (loi-cadre)

- Gouvernance hospitalière et planification territoriale de l'offre sanitaire à tous les niveaux
- Valorisation des ressources humaines
 - loi sur la fonction publique sanitaire (motiver les RH)
 - Réformer le système de formation
 - Ouverture sur les compétences étrangères et motivation des médecins marocains du monde à rentrer
- Mise à niveau de l'offre sanitaire
 - Amélioration de la qualité et répartition équitable des services
 - Obligation du respect du circuit des soins
 - Système d'accréditation des établissements publiques et privés
- Digitalisation du système de santé

Les ressources humaines: loi 09/22

- Protection juridique des fonctionnaires
 - contre toute menace et agression
- Obligation de MEP de formation continue
 - obligation d'y prendre part
- MEP de système permettant à certains professionnels de faire des tâches au privé,
 - dans le cadre du partenariat public-privé,
- Prévoir un système de rémunération efficient et motivant

La gouvernance loi 07/22

- Création de la Haute autorité de Santé:
- Instance indépendante du MSPS
 - Assure la pérennité d'action de l'Etat dans la santé
 - Assure l'encadrement technique de l' AMO
 - Evalue la qualité des prestations d'établissements
 - secteurs public et privé.
 - Emet des avis sur les politiques publiques de santé

La gouvernance loi 08/22

- Les groupements territoriaux de santé GTS
 - Regroupement du CHU et autres unités hospitalières régionales 
 - un seul établissement public autonome chargé de
 - soins hospitaliers, formation et recherche scientifique,
 - Objectif: mieux réguler l'offre publique de soins au niveau régional,

La gouvernance loi 10/22

- L'agence marocaine des médicaments et des produits de santé,
 - concrétiser les orientations stratégiques de l'Etat concernant la souveraineté médicamenteuse
 - Garantir la disponibilité, la sûreté et la qualité des médicaments et produits de santé.
- Régulation du marché de médicament.
 - Procédure d'enregistrement, homologation des produits et fournitures médical

La gouvernance loi 11/22

- L'agence Marocaine du sang et de ses dérivés
- Substitue le CNTSH et les CRTS
- Institution chargée de
 - exécuter les orientations stratégiques de l'Etat visant le développement d'un stock de sang pour subvenir aux besoins nationaux
 - garantir la disponibilité, la sûreté et la qualité de tous les produits dérivés de sang, quelles que soient les circonstances.

la protection sociale

loi cadre 09/21

- Décret d'application du 23/03/2021
- Elargir la CMO à tous des marocains en 2022,
 - 22 M de bénéficiaires supplémentaires de l'AMO.
- Généraliser les allocations familiales à 7 M d'enfants en âge de scolarisation en 2022

Adoption de la loi cadre sur la protection sociale 09/21 en 2021

- A horizon 2025:
 - élargir la base de cotisation aux régimes de retraite
 - intégrer 5 M de personnes actives
- Généralisation de l'indemnité perte d'emploi à aux personnes ayant un emploi stable.

- En effet, la mesure prévue pour deux ans devra générer 5 Mds de DH par an (au total 10 Mds de DH), alors que le financement de la généralisation de la protection sociale est estimé à 14,5 Mds de DH, selon le ministre des Finances.

Définition (loi 34 – 09)

- Le système de santé: ensemble des institutions, ressources et actions organisées pour réaliser les objectifs fondamentaux de santé
- sur la base des principes suivants :
 - la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, conservation et restauration de la santé ;
 - l'égalité d'accès aux soins et services de santé ;
 - l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;
 - la complémentarité intersectorielle ;
 - l'approche genre en matière de services de santé.
- La MEO des principes incombe principalement à l'Etat.

Définition (loi 34 – 09)

- Les actions de l'Etat en matière de santé;
 - La prévention,
 - L'éducation pour la santé;
 - La promotion de modes de vie sains,
 - Le contrôle sanitaire
 - Les prestation de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation.
- peuvent être sectorielles ou intersectorielles.

L'offre de soins : Définition

- Les ressources humaines, infrastructures des secteur public ou privé et installations de santé, fixes ou mobiles
- Les moyens MEO pour produire des prestations et services de soins pour répondre aux besoins de santé des individus et collectivités.

L'offre de soins

- Organisation
 - Répartition équilibrée et équitable sur le territoire national
 - Organisation synergique de secteurs public et privé
 - répondre aux besoins : offre de soins et services complémentaires, intégrés et coordonnés.
 - L'organisation : la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins (SROS)

Niveau central

L'Institut National d'Hygiène

- C'est l'organisme central des laboratoires de santé publique dont les missions sont:
 - Assurer l'appui technique et scientifique des programmes de santé;
 - Assurer des prestations de services et l'expertise de biologie médicale et de Santé Environnement ;
 - Participer aux réseaux nationaux et internationaux de surveillance à la veille et à la sécurité sanitaire ;
 - Contribuer à la formation dans les domaines de ses compétences et à la réalisation d'études et travaux de recherches

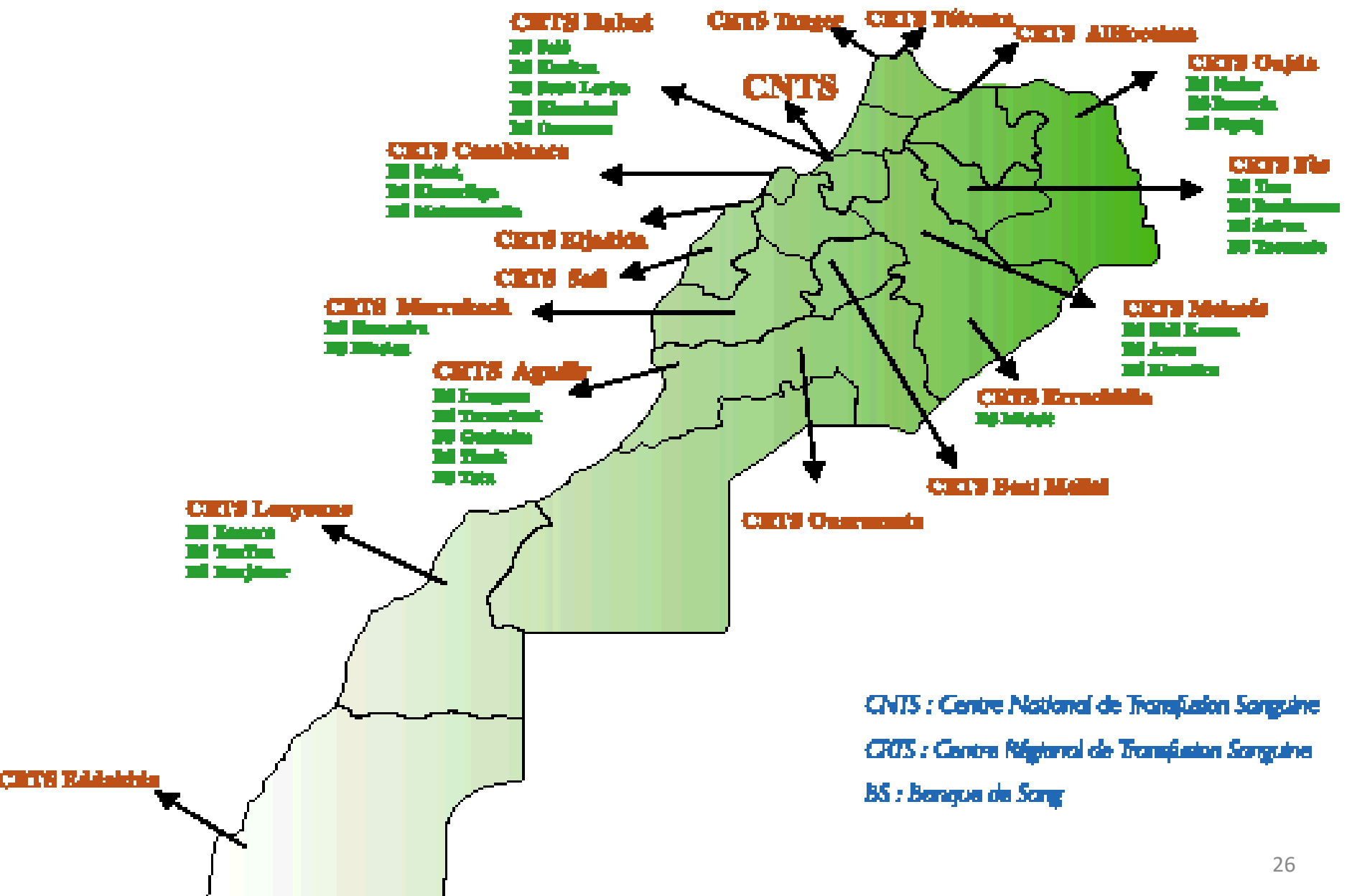
Le centre antipoison: CAPM

- 1989, CAPM a été développé au sein de l'INH.
- 2011: Centre Collaborateur de l'OMS (CCOMS) pour la pharmacovigilance
- Mission: assurer la Fonction Nationale de Vigilances et d'Alertes Sanitaires
 - Anticiper les risques des intoxications, événements indésirables et incidents liés aux produits de santé, de consommation et contaminants d'environnement.
 - Expertises techniques dans la PEC de patients intoxiqués

Le centre National de Transfusion sanguine et d'hématologie

- Organise la collecte et le groupage
- Approvisionne les hôpitaux en sang et en dérivés de sang
- Participe au dépistage de la syphilis, l'hépatite et le virus du SIDA

Réseau national de transfusion sanguine



L'Institut PASTEUR

les champs d'activités :

- Promouvoir et développer la recherche;
- Apporter sur des bases contractuelles une contribution d'expertise, d'analyses biologiques et conseil à tout individu, à toute entreprise, administration et autre institution régionale, nationale ou internationale;
- Fabriquer, importer et exporter, distribuer tous les vaccins, sérums, produits biologiques
- Contribuer à l'enseignement des disciplines biologiques liées à ces activités.

Le Laboratoire National de Contrôle du médicament

- Procède à l'analyse et à l'inspection des médicaments et produits pharmaceutiques
- Inspecte les unités de fabrication et les circuits de distribution des médicaments et produits pharmaceutiques
- Procède aux essais et aux dosages permettant de vérifier que les médicaments sont conformes aux normes

Ecole Nationale de santé Publique(ENSP)

- Missions:
 - **Formation initiale**
 - filières de spécialisation en santé publique et en management de la santé, Médecine de famille
 - Profils variés : médecins, pharmaciens, infirmiers
 - **Formation continue,**
 - **Recherche scientifique**
 - **Expertise.**

Centre National de Radioprotection

- Le secteur médical : premier usager des rayons ionisants et des techniques nucléaires au Maroc: diagnostic ou thérapie.
- l'utilisation comporte des risques.
- Patients et personnel médical et paramédical sont-ils suffisamment protégés contre ces risques au Maroc ?

Centre National de Radioprotection et Centre National de l'Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN)

- CNR :Ministère de la Santé
- CNESTEN : Ministère de la Santé et Ministère de l'Énergie et des Mines, autorité nationale compétente en matière de sûreté nucléaire.
 - l'expertise de radioprotection,
 - le contrôle de qualité,
 - la surveillance dosimétrique,
 - l'étalonnage des équipements,
 - le transport
 - et la gestion des sources radioactives usées (déchets)
 - ainsi que la formation spécifique à la manipulation de ces sources et l'exposition à leur rayonnement.

Offre de santé dans le secteur publique

Décret n° 2-14-562 du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) pris pour l'application de la loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, en ce qui concerne l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins.

Infrastructure : ressources humaines (2021)

- Médecins tous secteurs: 27095:7,4/10000 hab
 - 52,4% dans le secteur privé
- Paramédicaux public: 31657: 9,7/10000 Hab
- Recommandation de l’OMS:
 - Seuil de 22,8 professionnels qualifiés/10000habt* pour atteindre 80% de la couverture médicale
 - Seuil de 41,1/10000 habits pour une couverture universelle (2030) **

• Anand S , Bärnighausen T . Human resources and health outcomes: cross-country econometric study. Lancet 2004;364:1603–9.doi:10.1016/S0140-6736(04)17313-3

• ** Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>).

Le mode fixe

ART. 7. – L'offre de soins dans le secteur public est régie par le principe de gradation des niveaux de soins qui repose sur un système de référence et de contre référence, qui régule les parcours de soins des patients en dehors des situations d'urgence. Ce système peut être organisé à l'intérieur du même territoire de santé sous forme de réseaux coordonnés de soins, ou entre les territoires de santé sous forme de filières de soins.

Le mode fixe

ART. 5. – L'offre de soins en mode fixe dans le secteur public est composée des quatre réseaux d'établissements de santé relevant du ministère de la santé ou placés sous sa tutelle, suivants :

- le réseau des établissements de soins de santé primaires (RESSP) ;
- le réseau hospitalier (RH) ;
- le réseau intégré des soins d'urgence médicale (RISUM) ;
- le réseau des établissements médico-sociaux publics (REMSP).

Le mode mobile

- visites à domicile (VAD) ;
- unités médicales mobiles (UMM) ;
- caravanes médicales spécialisées (CMS) ;
- hôpitaux mobiles (HM).

Niveau périphérique

ART. 10. – Les territoires de santé sont constitués :

- des circonscriptions sanitaires ;
- des préfectures et provinces sanitaires ;
- des régions sanitaires ;
- des territoires de santé inter-régionaux.

Sous-section première. – De la circonscription sanitaire

La région sanitaire

- La région sanitaire constitue le champ d'intervention de la DRS
- La DRS assure la coordination entre les établissements de santé publics et privés dans le cadre du partenariat.

Organisation régionale



Le Service de la Santé Publique et de la Surveillance Epidémiologique relevant de la Direction Régionale de la Santé est chargé, selon l'arrêté du 13 mai 2011, de développer dans la région la mission du Ministère de La Santé dans le domaine de Santé l'Environnement

Les délégations provinciales et préfectorales

- Dirigée par un délégué provincial
- Les préfectures et provinces sanitaires:
 - ressorts territoriaux des préfectures et provinces
- découpées en circonscriptions sanitaires.

Les délégations provinciales et préfectorales

- Service du réseau des établissements de soins (SRES)
 - chargé d'élaborer les plans d'action des établissements des soins de santé primaire(E.S.S.P), en matière de prévention et de soins et de veiller à l'encadrement, au suivi et à l'évaluation de leur exécution.

La circonscription sanitaire

ART. 11. – La circonscription sanitaire représente le territoire de base dans le découpage sanitaire pour la planification de l'offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d'actions sanitaires, dont l'ensemble des prestations de soins de santé primaires relatives à la prévention, à la promotion de la santé et aux modes de vie sains, ainsi qu'aux soins liés à l'accouchement, aux urgences de proximité et à la médecine générale, doit être disponible.

Réseau de soins de santé primaire

ART. 21. – Le réseau des établissements de soins de santé primaires est constitué des établissements suivants :

- les centres de santé ruraux et urbains de premier niveau ;
- les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ;
- les dispensaires ruraux lorsqu'ils existent.

Il comprend en outre, des structures spécialisées d'appui aux établissements précités.

ART. 22. – Le centre de santé rural de premier niveau est l'établissement de soins de santé primaires de premier contact en milieu rural.

Le centre de santé rural de premier niveau est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major. Il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la surveillance épidémiologique notamment, les prestations suivantes :

- les consultations de médecine générale ;
- les soins infirmiers ;
- le suivi de la santé de la mère et de l'enfant ;
- le suivi des maladies chroniques ;
- le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire ;
- les prestations d'information et d'éducation pour la santé.

Le centre de santé rural

La création et le lieu d'implantation de chaque centre de santé rural de premier niveau sont décidés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins.

Lorsque le territoire de desserte du centre de santé rural de premier niveau est étendu, il est possible de créer en plus dudit centre, un ou deux dispensaires ruraux qui lui sont rattachés et qui sont placés chacun sous la responsabilité d'un(e) infirmier(e).

Le centre de santé rural

ART. 23. – Le centre de santé rural de deuxième niveau est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major. Il offre outre, les prestations fournies par le centre de santé rural de premier niveau notamment, les prestations suivantes :

- les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ;
- les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ;
- les examens d'échographie obstétricale.

Lorsque le centre de santé rural de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière publique, le centre est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et offre en plus :

- des prestations d'urgence médicale de proximité ;
- des soins bucco-dentaires ;
- des consultations de santé mentale.

Le centre de santé urbain

ART. 24. – Le centre de santé urbain de premier niveau est l'établissement de santé de premier contact en milieu urbain.

Le centre de santé urbain de premier niveau est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major, et il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la surveillance épidémiologique notamment, les prestations suivantes :

- les consultations de médecine générale ;
- les soins infirmiers ;
- le suivi de la santé de la mère et de l'enfant ;
- le suivi des maladies chroniques ;
- le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire ;
- les prestations d'information et d'éducation pour la santé.

La création et le lieu d'implantation de chaque centre de santé urbain de premier niveau sont décidés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins.

ART. 25. – Le centre de sante urbain de deuxieme niveau est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.

Outre les prestations fournies par le centre de santé urbain de premier niveau, le centre de santé urbain de deuxième niveau assure notamment les prestations suivantes :

- les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB), y compris 4 à 8 lits d'accouchement au besoin ;
- les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques.

Lorsque le centre de santé urbain de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu de la commune de rattachement ne disposant pas de structure hospitalière publique, il offre en outre :

- des prestations d'urgence médicale de proximité ;
- des soins bucco-dentaires ;
- des consultations de santé mentale.

Critères de création

- un centre de santé rural de premier niveau : pour une population minimale de desserte de 7.000 habitants ;
- un centre de santé rural de deuxième niveau : pour une population minimale de desserte de 25.000 habitants ;
- un centre de santé urbain de premier niveau : pour une population minimale de desserte de 25.000 habitants ;
- un centre de santé urbain de deuxième niveau : pour une population minimale de desserte de 50.000 habitants.

Le RSSP en milieu rural se distingue par 2 modes de couverture sanitaire :

- Le mode fixe : les usagers des services de santé à se déplacer pour bénéficier des services offerts ;
- Le mode mobile (= Itinérance): pour la population du territoire ne pouvant se déplacer du fait de son éloignement (problème d'accessibilité géographique). Il permet la fourniture de prestations sanitaires à domicile ou à proximité.
 - Itinérance à domicile
 - Itinérance par point de contact ou par équipe mobile

Réseau de soins de santé primaire (2021)

- 2985 établissement:
 - 1ESSP/12304hab
 - urbain 861 : 680 CSU-1 et 181 CSU-2
 - rural 2124 : 863 CSR-1 et 433 CSR-2
 - 2993 médecins dont 908 dans le milieu rural

Le réseau intégré des soins d'urgences médicale

- L'offre de soins d'urgences médicales comporte les prestations suivantes:

1. les Urgences Médicales de Proximité (U.M.P), assurées par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercles ;

2. les Urgences Pré-hospitalières (UPH), assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation (SMUR) et les services médicaux hélicoptérés (HELISMUR) ;

3. les Urgences Médico-hospitalières

Réseau Intégré des Soins Médicaux d'Urgence RISMU (2021)

- Urgences médicales de proximité: 89 unités
- Urgences pré-hospitalières
 - 111 ambulances de SMUR
 - 1265 ambulances de secours de base
- Urgences Médico-Hospitalières (UMH)
 - 149 UMH:
 - 1052 lits d'urgences et 536 lits de réanimation

Le réseau d'établissement médico-sociaux publiques (128 en 2021)

ART. 40. – Le réseau des établissements médico-sociaux publics est composé des :

- centres dits espaces « santé-jeunes » ;
- centres de rééducation physique, d'orthoptie et d'orthophonie ;
- centres d'appareillage orthopédique ;
- centres d'addictologie ;
- centres médico-universitaires ;
- centres de soins palliatifs.

Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de la santé.

Le réseau hospitalier (2021)

- 165 en 2021: 26711 lits
- 18 hôpitaux régionaux
- 74 hôpitaux provinciaux
- 35 hôpitaux de proximité
- 10 Hôpitaux psychiatriques

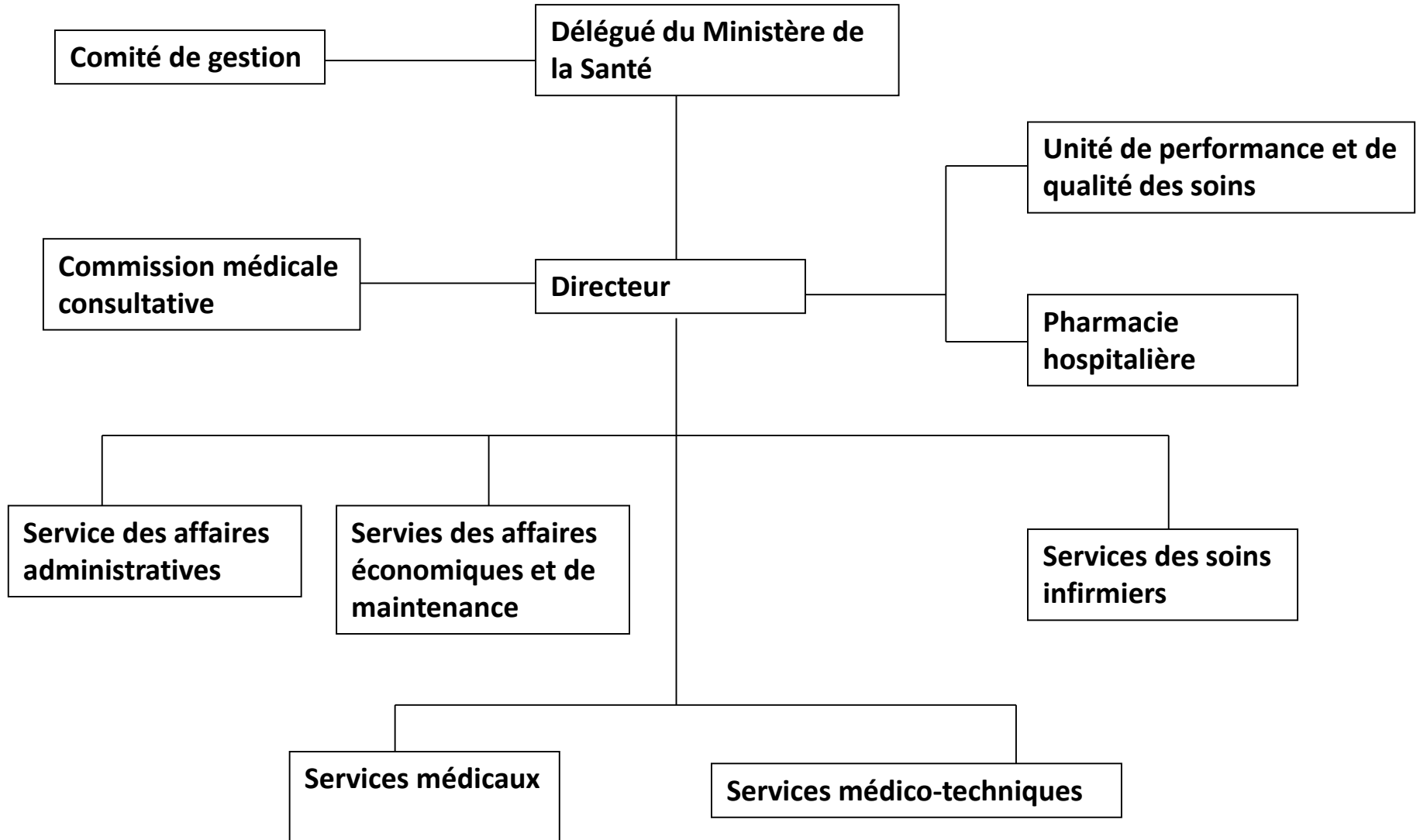
Organisation d'un hôpital

- Pôle des soins infirmiers
 - La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux,
 - L'évaluation de leur qualité et performance,
 - La contribution à la prévention des infections nosocomiales;
 - La planification et la gestion des ressources destinées au personnel paramédical

Organisation d'un hôpital

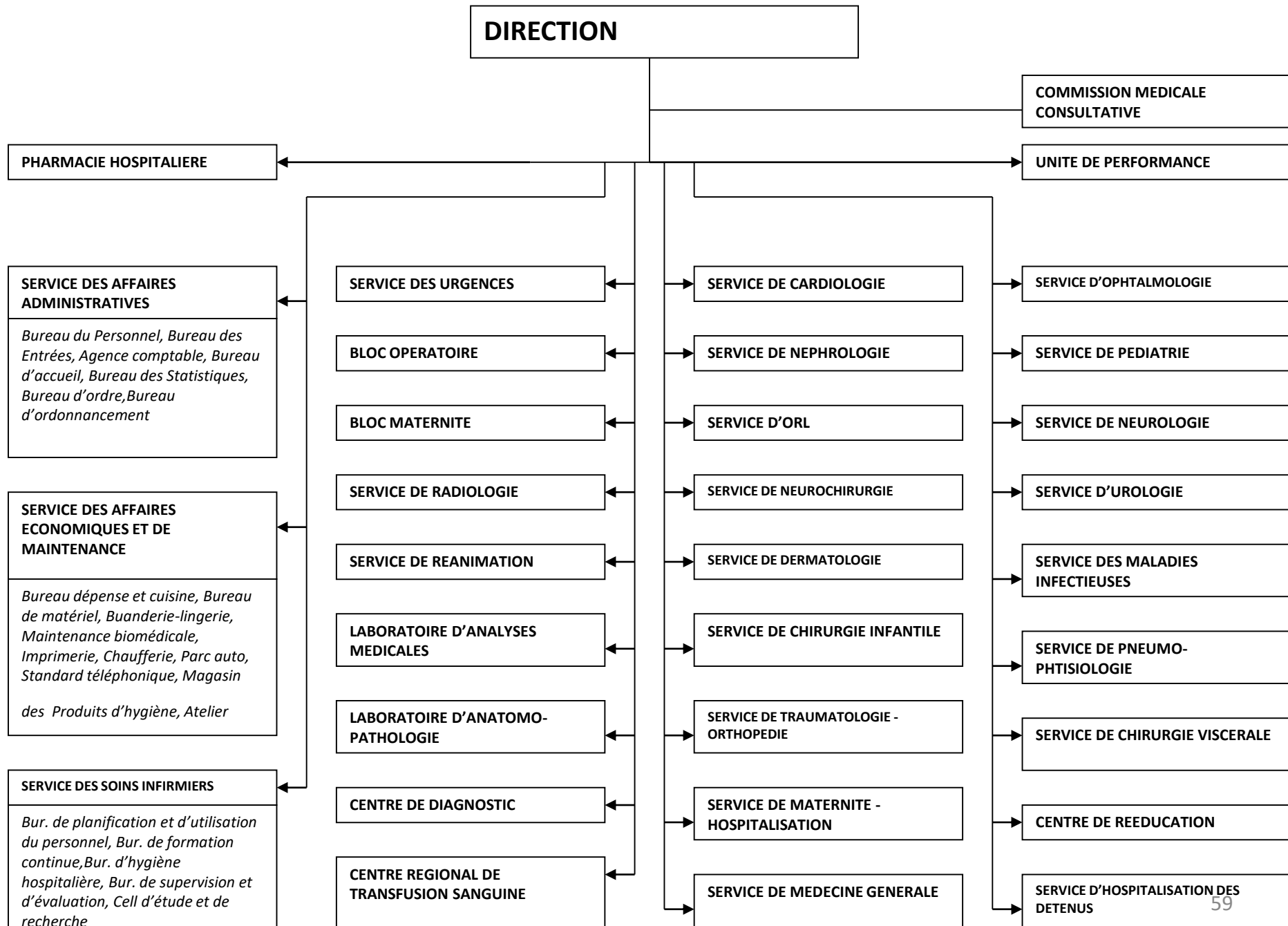
- Pôle des affaires administratives
 - Gestion administrative du personnel
 - Gestion budgétaire, financière et comptable ;
 - Approvisionnement et distribution en médicaments, fongibles, et autres produits
 - Nettoyage et sécurité des bâtiments
 - Gestion des déchets hospitaliers ;
 - Gestion et maintenance des équipements médicaux et *
 - installations techniques, des bâtiments et mobiliers ainsi que du p

Organisation d'un hôpital



NB. : Cet organigramme ne s'applique pas aux CHU qui ont un statut autonome

ORGANIGRAMME D'UN HOPITAL



Le Réseau d'Établissements Hospitaliers :

1er niveau

- Hôpital de proximité: hôpital général dans lequel s'exerce la médecine et la chirurgie générale, la pédiatrie et l'obstétrique avec une activité d'urgences.

- Le Centre Hospitalier Provincial ou Préfectoral (CHP) :

Il comporte en plus des disciplines de base, les spécialités médicales et chirurgicales

Exemples : l'ophtalmologie, la dermatologie-vénérologie-léprologie, les maladies infectieuses, l'oto-rhino-laryngologie, la psychiatrie, la pneumo-phthisiologie, la cardiologie, la gastrologie, l'endocrinologie, la traumatologie-orthopédie et la réanimation médicale et chirurgicale.

Le Réseau d'Établissements Hospitaliers : le CHP

ART. 32. – Chaque centre hospitalier provincial ou préfectoral se compose de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la santé implantés dans son ressort territorial, y compris les hôpitaux de proximité ou les cliniques de jour. Il dispense les prestations de soins hospitaliers de premier niveau.

Le Réseau d'Établissements Hospitaliers : 2ème niveau

- Le Centre Hospitalier Régional (CHR) : un ou plusieurs hôpitaux généraux et spécialisés. Sa capacité et la dimension de son plateau technique varient selon l'importance de la population à desservir et la nature des disciplines qui y sont développées.

ART. 32. – Chaque centre hospitalier provincial ou préfectoral se compose de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la santé implantés dans son ressort territorial, y compris les hôpitaux de proximité ou les cliniques de jour. Il dispense les prestations de soins hospitaliers de premier niveau.

Exemple

Centre Hospitalier Régional de Fès	Hôpital Al Ghassani (chef lieu)
	Hôpital Ibn Al Khatib
	Hôpital de Proximité Ibn Baitar

Le Réseau d'Établissements Hospitaliers : 2ème niveau

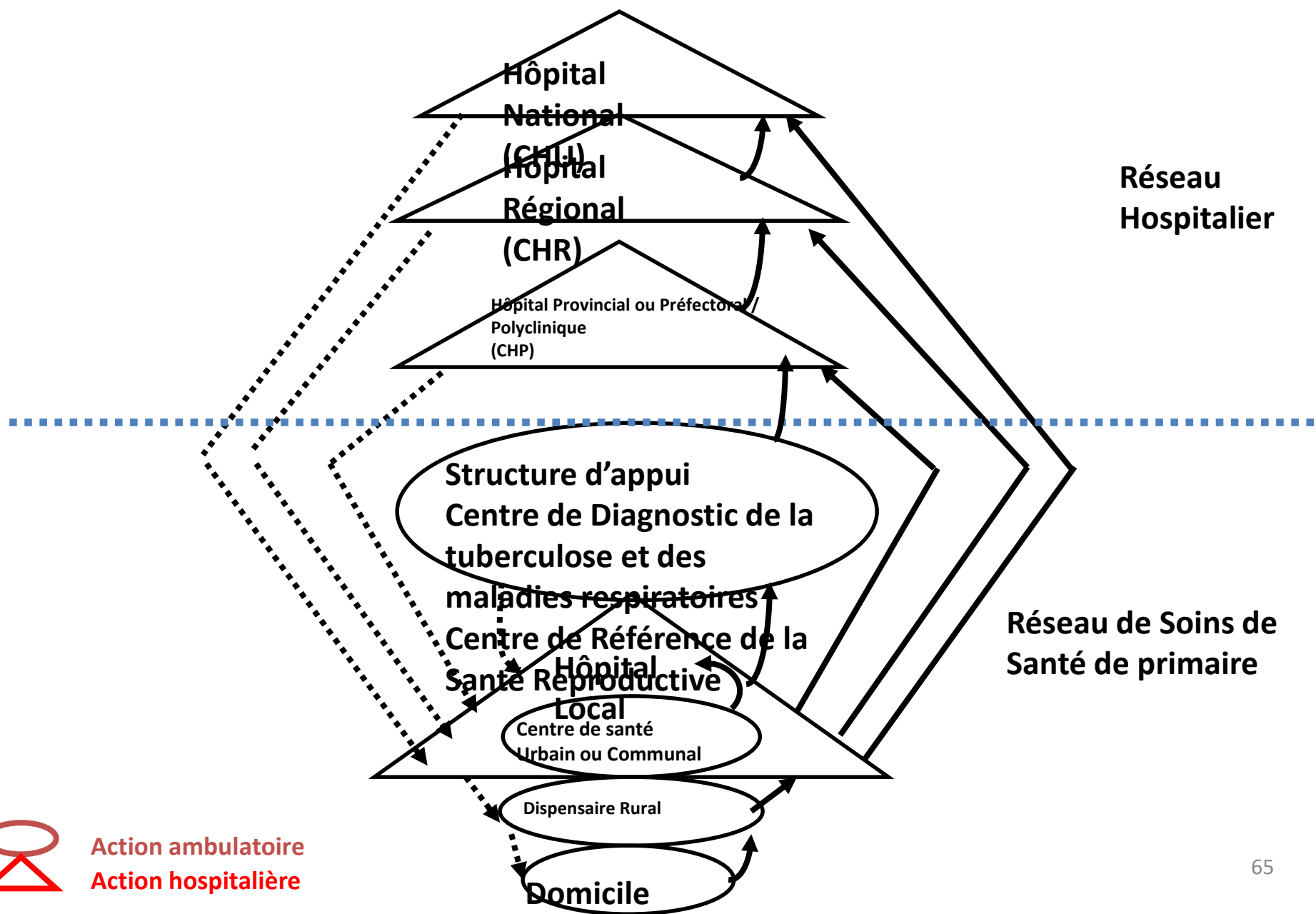
ART. 34. – Les centres hospitaliers interrégionaux sont composés des établissements relevant des centres hospitaliers à vocation interrégionale. Ils dispensent les prestations de soins hospitaliers de troisième niveau.

Ils comportent un ou plusieurs pôles d'excellence ou centres de référence à vocation interrégionale ou nationale.

Le Réseau d'Établissements Hospitaliers : 3ème niveau

- Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) : Il est constitué d'un ensemble d'établissements comprenant une gamme complète de services hautement spécialisés.
- Le centre hospitalier universitaire est un centre d'enseignement et de recherche, son influence s'étend sur la région et pour certaines disciplines à l'ensemble du pays.
- Il comporte en plus des disciplines existantes au niveau du CHR, les disciplines qui ont un caractère national
 - Exemples : la cancérologie, la chirurgie réparatrice, la chirurgie cardio-vasculaire et l'hématologie clinique.

LE CIRCUIT DU MALADE DANS LE SECTEUR PUBLIC



Structures d'appui et d'intervention

Tous les établissements du RSSB sont appuyés par des structures d'appui et d'intervention :

- Le Centre de Référence pour la planification familiale (CRPF) : centre de consultation, d'information et de formation pour les activités de contraception et de fertilité.
 - Son rôle est d'appuyer les établissements sanitaires des soins de santé de base qui fournissent des prestations de planification familiale.

Le CDTMR

- Le Centre de Diagnostic de la Tuberculose et des Maladies Respiratoires: 67 centres en 2021
- Rôle :
 - Établir ou confirmer le diagnostic de la tuberculose et des Maladies Respiratoires et prescrire l'hospitalisation des malades
 - Indiquer le traitement ambulatoire des malades sortant de l'hôpital Provoquer des enquêtes de dépistage autour des cas
 - Tenir un registre des cas de tuberculose
 - Évaluer les activités de la lutte antituberculeuse

Les bureau communaux d'hygiène

- service technique de la commune
 - tutelle du Ministère de l'intérieur
 - chargé de la veille sur l'état de propreté et de la salubrité de l'environnement de la population.
- Missions: surveillance et contrôle de l'hygiène
 - établissements industriels, ateliers et chantiers
 - salubrité de voirie, égouts et points d'eau
 - gestion des déchets liquides et solides
 - contrôle de qualité des aliments
 - stockage, transport, lieux de vente, personnel

Les bureau communaux d'hygiène

- Lutte contre les rongeurs : dératisation
- Lutte contre les vecteurs de maladies
 - gestion du centre antirabique
 - consultation et le traitement sero-vaccinal.
 - traitement des personnes mordues par les chiens ou autres animaux
- L'activité médico-légale : le médecin du BCH
 - Confirme chaque décès et s'assure de sa nature
 - naturelle : délivrer le certificat de décès et permis d'inhumer
 - Suspecte: aviser le procureur du Roi pour examen médico-légal.
- Registre de naissances et décès : idée sur l'évolution démographique

Secteur privé

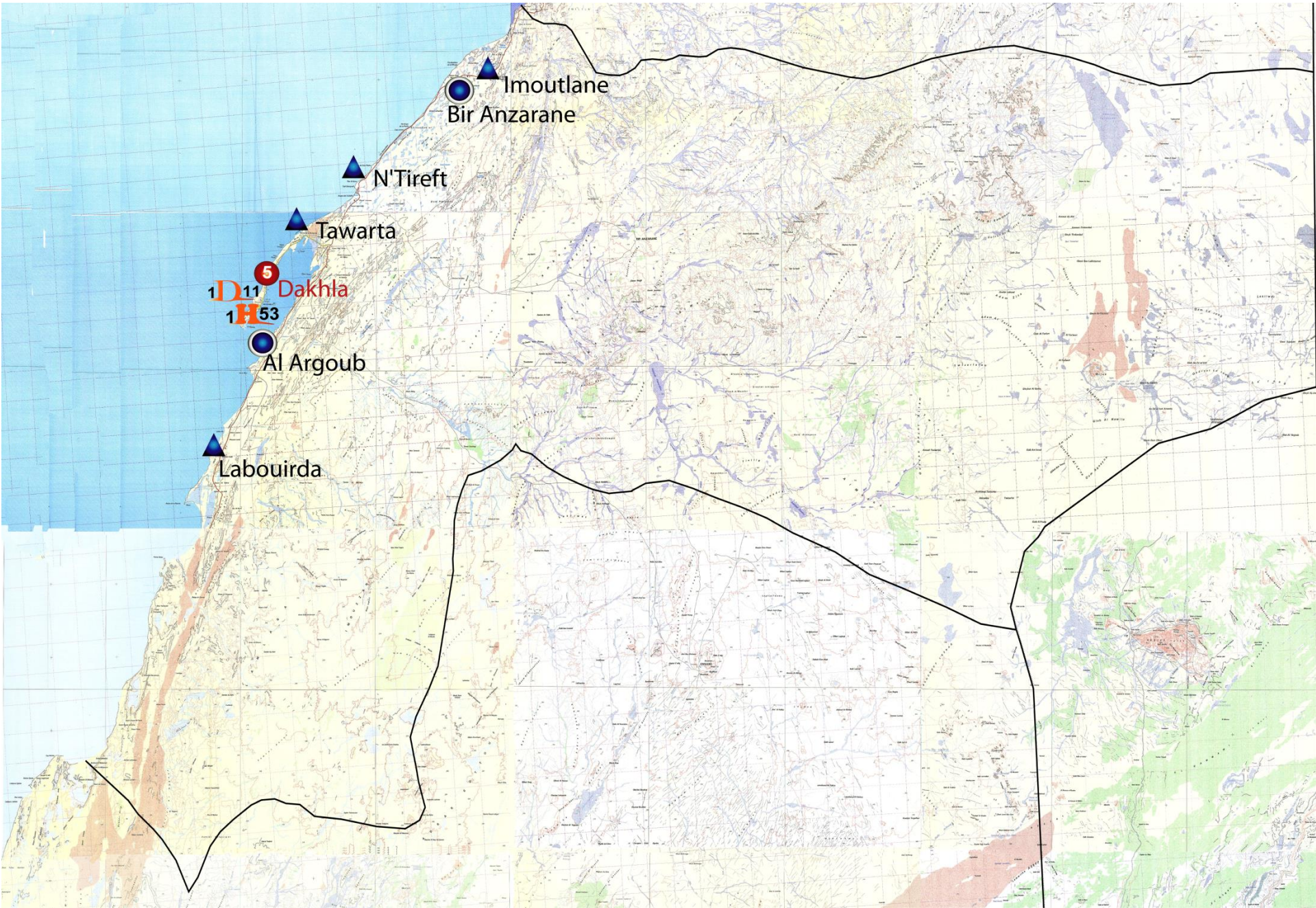
- 384 cliniques: 12534 lits
- 308 cabinets de radiologie
- 9603 officines de pharmacie
- 4416 cabinets dentaires
- 234 centres d'hémodialyse

La carte sanitaire et le SROS

- La carte sanitaire et le SROS ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en vue de
 - satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population,
 - réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines,
 - corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux
 - maîtriser la croissance de l'offre.

La carte sanitaire

- La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l'offre et notamment les:
 - types d'infrastructures et installations sanitaires,
 - normes et modalités de leur implantation territoriale.
- La carte sanitaire est établie sur la base de
 - l'analyse globale de l'offre de soins existante,
 - données géo-démographiques et épidémiologiques
 - en fonction du progrès technologique médical.



Imoutlane
Bir Anzarane

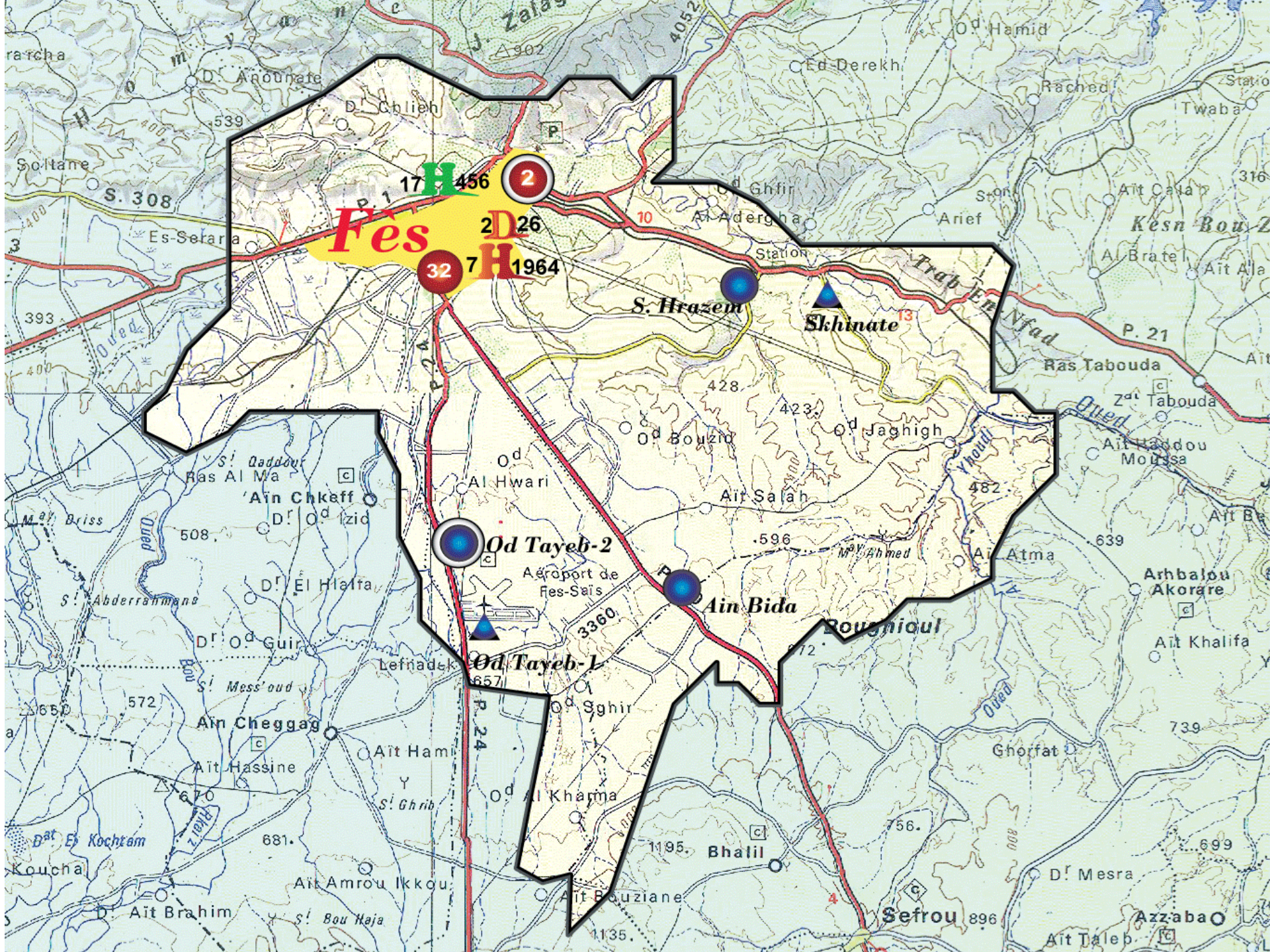
N'Tireft

Tawarta

5
1D11
1H53
Dakhla

Al Argoub

Labouirda



SROS

- Le SROS est un outil de planification et d'organisation de l'offre de soins au niveau régional.
 - Il détermine par préfecture ou province, eu égard à la carte sanitaire:
 - l'inventaire de l'infrastructure sanitaire existante ;
 - la projection des établissements de santé, des lits
 - la répartition territoriale et projections des ressources
 - Le SROS sera établi par la direction régionale de la santé pour une période de 5 ans,

La filière de soins et réseau de soins

- Filière de soins:
 - Organisation verticale hiérarchisée de prise en charge
 - Niveaux de recours aux soins organisés selon
 - la nature de la morbidité
 - les protocoles thérapeutiques quand ils existent
 - **Centrée sur les structures de soins**
- Réseau de soins
 - Organisation **horizontale, non hiérarchisée**
 - Coordination de PEC médicale multidisciplinaire
 - Centrée sur les structures de soins

Objectifs

- Faciliter l'accès (Porte d'entrée)
- Assurer la continuité et orientation de soins
- Optimiser les ressources: Orienter selon le besoin et éviter la sur/sous utilisation
- Développer les synergies entre structures
- Mettre en place des protocoles de PEC

Filière de soins

- Filière générale: RAMED
 - Première porte d'entrée obligatoire : Le CS de rattachement au domicile du bénéficiaire, dont le nom est inscrit sur la carte RAMED
 - En cas de besoin, le médecin du CS réfère à la structure hospitalière la plus proche et adaptée dans la filière de soins dans la province : hôpital local, provincial, ou hôpital spécialisé
 - Si les prestations ne sont pas disponibles, le médecin hospitalier réfère vers le centre hospitalier régional dont il relève

I. 4 - Les structures de santé des Forces Armées Royales :

L'organisation de celles-ci est fixée par l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale.

- Hôpital militaire d'instruction Mohamed V
- Hôpital militaire de Marrakech
- Hôpital militaire de Meknès

II – Le secteur privé (libéral) à but lucratif

- Les établissements de du secteur privé sont constitués des :
 - cabinets médicaux (médecine générale et spécialité) ;
 - cabinets de radiologie et d'imagerie médicale ; installations d'assistance médicale urgente ;
 - cabinets de médecine dentaire ;
 - cliniques;
 - établissements médico-sociaux de prise en charge médicalisée des personnes âgées et à besoins spécifiques
 - laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
 - officines de pharmacie et dépôts de médicaments ;
 - cabinets paramédicaux.

Le secteur privé (libéral) à but lucratif: 2019

- 359 Cliniques privées (10 346 Lits)
- 9671 cabinets médicaux
- 8997 officines;
- 3614 cabinets dentaires
- 268 cabinets de radiologie
- 550 laboratoires
- 13545 Médecins dont 62% de spécialistes

II – Le secteur privé (libéral)

- chaque type d'établissements est soumis, pour les conditions et procédures d'ouverture et d'exploitation aux dispositions réglementaires
- Les établissements de santé privés peuvent participer à des actions de santé publique
 - dans le cadre de la complémentarité entre secteurs.
 - des modes de partenariat public-privé seront mis en place

II – Le secteur privé (libéral) à but lucratif

- Il répond essentiellement aux besoins de soins curatifs
- Il est caractérisé par :
 - La liberté d'installation du médecin
 - Le libre choix du médecin par le malade
 - La liberté de prescription
 - Le paiement directe des honoraires

III - Secteur mutualiste et autres (secteur semi-public à but non lucratif)

III. 1 - La CNSS

- Dispose de 13 cliniques d'une capacité de 1092 lits :

(5 cliniques à Casablanca , 1 clinique à Agadir, El Jadida, Kénitra, Marrakech, Mohammedia, Oujda, Settat, et Tanger)

III. 2 - La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS, 1963)

- Dispose de plusieurs unités de soins
- Cliniques
- Centres de radiologie
- Centres de soins dentaires
- etc

III. 3 - Croissant Rouge marocain et fondations

3 cliniques du Kénitra, Tanger, Tétouan

Quelques établissements des fondations et des ligues

Les fondations

- Exemple :
 - hôpital Cheikh Zayed
 - Hôpital universitaire à Rabat
 - 3 hôpitaux multidisciplinaire à khouribga, benguerir et youssoufia
 - Hôpital Cheikh Khalifa Ben Zayed
 - Fondation de neurochirurgie (Hôpital des spécialité de Rabat..)

IV - Le secteur traditionnel

IV. 1 – Définition

La médecine traditionnelle est l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques explicables ou non pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental et social en s'appuyant exclusivement sur l'expérience vécue et l'observation transmise de génération en génération oralement ou par écrit.

IV - Le secteur traditionnel

2 – Caractéristiques

- **Même but que celui des autres secteurs**
- **Dépend des particularités culturelles**
- **Secteur qui n'évolue pas car délaissé par le personnel de santé qualifié**
- **Secteur très large**

IV - Le secteur traditionnel

3 – Médecine traditionnelle et médecine moderne

Synthèse du système traditionnel et moderne possible ?

Raisons de la promotion de la médecine traditionnelle :

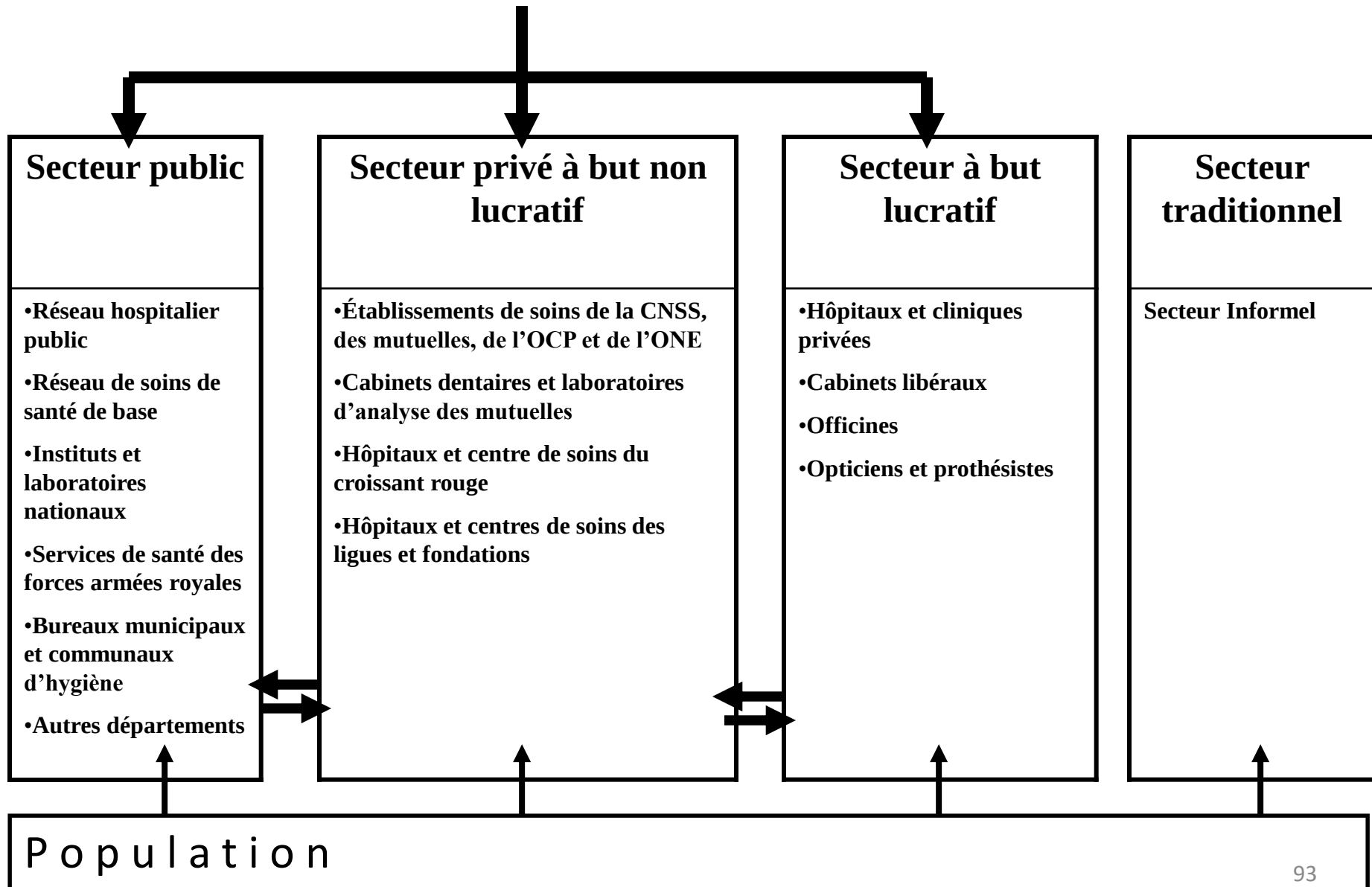
- **Respect de l'héritage culturel**
- **Approche globale de l'homme**
- **Contribution au développement de la médecine universelle**
- **Méthodes parfois acceptables**
- **Aspects économiques à prendre en compte**

IV - Le secteur traditionnel

intégration de ce secteur :

Avantages	Inconvénients
•Renforcement des 2 systèmes •Améliore la connaissance et sa diffusion en matière de soins de santé •Renforcement des compétences	•Problème de la transplantation culturelle •Impossibilités d'intégrer certains aspects (spirituelles et autres) •Motivations trop commerciales •Effets iatrogènes •Problème de la qualification du personnel et de son statut •Résistance des 2 parties

Système national de santé



V – Le conseil de l'ordre et déontologie

Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans le secteur public, soit dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité d'enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires soit dans les Forces armées royales.

V – Le conseil de l'ordre et déontologie

- ***L'Ordre national des médecins***
- « a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine »

V – Le conseil de l'ordre et déontologie

- L'Ordre regroupe obligatoirement tous les médecins exerçant au Maroc. « Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale s'il n'est inscrit à l'Ordre national des médecins ».

- Conseil National
- Conseils régionaux

V – Le conseil de l'ordre et déontologie

- Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre;
- Il examine les questions relatives à l'exercice de la profession médicale qui lui sont confiées par le législateur;
- Il émet son avis sur les lois et règlements relatifs à l'exercice
- Il participe à l'élaboration et l'exécution de la politique de santé et la carte sanitaire
- Il représente la profession médicale auprès de l'administration
- Il défend les intérêts moraux et professionnels de la profession médicale
- Il organise la protection sociale de ses membres
- Il établit le code de déontologie
- Toute activité médicale lui est interdite

V – Le conseil de l'ordre et déontologie

Code de la déontologie

- Ensemble de règles qui s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre :
 - Devoirs généraux des médecins
 - Devoirs des médecins envers les malades
 - Devoirs des médecins envers les collectivités
 - Devoirs de confraternité
 - Devoirs des médecins envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux
 - Dispositions diverses

VI – L'industrie pharmaceutique

- Historique
 - 1965, une circulaire du MS impose la fabrication locale progressive des différentes formes pharmaceutiques.
 - Maroc ne comptait que 8 unités industrielles en 1965, il en est à plus de 25 dans les années 80

VI – L'industrie pharmaceutique

- L'investissement a suivi cette courbe ascendante.
 - 100 millions MAD en 1990,
 - 250 millions MAD en 1995 et 259 millions en 2009
- L'IP Marocaine se place au 2ème rang en Afrique, après l'Afrique du Sud.
 - Chaque année, près de 300 millions de Dhs sont investis dans nos usines
- le secteur exporte 8 % de sa production
 - en 2013: 909 Millions de Dirhams (+21,7% / 2012)

VI – L'industrie pharmaceutique

SYNTHESE	LES CHIFFRES CLES 2014
Nombre de Sites	32
Nombre de laboratoires	19 sociétés nationales et multinationales
Nombre de présentations pharmaceutiques	6000 spécialités enregistrées au Ministère de la santé
Fabrication locale	65 % de la demande
Exportations	8 % environ de la production
Consommation par habitant	414 Dhs/an (2013)
Qualité	Conforme aux normes Internationales

VI – L'industrie pharmaceutique

- L'industrie pharmaceutique Marocaine est réputée être aux normes internationales
- L'étroitesse du marché national entraîne une sous-utilisation de l'outil industriel.
- Le marché pharmaceutique marocain reste très fluctuant
 - La faiblesse du pouvoir d'achat
 - L'absence ou de la faible couverture sociale (seulement 8 Millions de bénéficiaires de l'AMO)

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 1 – La Consommation du médicament

En 2010:

- le chiffre d'affaires national :7,9 milliards de dirhams pour la partie privée (médicaments vendus en pharmacies).
- L'évolution par rapport à 2009 :+1% en volume et de +2% en valeur.
- une dépense annuelle liée à l'achat des médicaments :12,6 milliards de dirhams

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 1 – La Consommation du médicament

- Les dépenses annuelles per capita, liées à l'achat des médicaments dans les pharmacies sont estimées à 376 Dhs (46 USD),
 - En 1990: 120 DH
 - l'Américain consomme 770 USD / an,
 - le Japonais 506 USD et l'Européen 380 USD.
- En volume, la consommation per capita est de l'ordre de 8,6 boîtes par personne par an.

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 1 – La Consommation du médicament

- Le secteur privé domine totalement, la production, l'importation et la distribution en gros ou au détail des médicaments
 - 8914 officines (2018) qui couvrent l'ensemble du territoire marocain

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 2 - Réglementation du prix du médicament

- *a) L'autorisation de mise sur le marché :
AMM*

Tout médicament fabriqué industriellement, importé ou exporté, doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une autorisation délivrée par l'administration.

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 2 - Réglementation du prix du médicament

b) Le système de fixation des prix des médicaments

- en vigueur dès les années 60 et en cours de changement
- le prix accordé à un laboratoire pour un médicament est calculé sur la base du prix dans le pays d'origine selon deux procédures,
 - l'une concerne les médicaments fabriqués au Maroc
 - l'autre pour les médicaments importés.

VI – L'industrie pharmaceutique

VI. 2 - Réglementation du prix du médicament

b) Le système de fixation des prix des médicaments

- Le prix accordé au 1er générique est inférieur de 30% par rapport au médicament princeps
- Le prix accordé à chacun des génériques suivants est inférieur de 5% par rapport au prix du générique qui l'a précédé.

– L'industrie pharmaceutique

- Des défis restent à relever :
 - Accessibilité de la population au médicament (géographique et économique)
 - Renforcement de la qualité
 - Surveillance et vigilance pour mieux protéger la population